

ETAT DU MONTANA - DÉPARTEMENTS **DE SANTÉ MENTALE - ASILE** **RAVENSHADE**

IDENTIFICATION DU PATIENT

Identification : 17949

Nom : PARKER

Prénom : ELISE

Sexe : FÉMININ

Âge : 27 ANS

Date de naissance : 03/06/1998

Numéro de dossier : RS-EU-021-26

Date d'admission : 05/02/2025

Service : IDENTIFICATION DU PATIENT

MÉDECIN RÉFÉRENT

Nom : Dr Viktor Koskov

Spécialité : Neurologie / Psychiatrie expérimentale

MOTIF D'HOSPITALISATION

Trouble anxio-dépressif sévère

Épisodes de stress aigu

Suspicion de trouble post-traumatique

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX

Aucun antécédent neurologique connu

Suivi psychologique antérieur (non détaillé)

Aucun traitement lourd avant admission

ROTOCOLES APPLIQUÉS

1. PRC – Réalignement Cognitif

- Dates : 9/06 – 12/06 – 16/06
- Intensité : Progressive (niveau 2 → 4)
- Réaction :
 - Désorientation immédiate
 - Perte de mémoire récente
 - Réduction des réponses émotionnelles

2. Programme M-695

- Dates : 20/06 – 23/06
- Substance administrée : Non spécifiée
- Résultats :
 - Amnésie partielle
 - Confusion identitaire
 - Difficulté à reconnaître proches

3. Isolement “Silence Blanc”

- Durée : 48h (24/06 → 26/06)
- Observation :
 - Hallucinations auditives et visuelle
 - Perte de repères temporels
 - Dégradation rapide de l'état mental (violence)

SUIVI CLINIQUE (EXTRAITS)

16/07/2025

- Patient coopératif. Légère anxiété.

20/06/2025

- Début troubles mental. Discours confus.

23/06/2025

- Désorientation marquée. Difficulté à reconnaître personnel.

28/06/2025

- Refus de s'alimenter. Crises d'angoisse.

5/07/2025

- État instable. Recommandation : intensifier protocole.

OBJECTIF – NOTES PERSONNELLES

Dr Viktor Koskov

Je ne soigne pas.

Je corrige une erreur fondamentale :

la croyance que l'identité humaine est stable.

Elle ne l'est pas.

Elle est conditionnée. Malléable. Réinscriptible.

POSTULAT

Le cerveau ne perçoit pas la réalité.

Il la construit.

Chaque individu vit dans une version interne du monde, validée uniquement par la répétition et le consensus.

Briser ce consensus...

c'est isoler un esprit.

Et un esprit isolé devient modifiable.

PROTOCOLE : INDUCTION SENSORIELLE FORCÉE

Expérience non déclarée.

Non archivée.

Non reconnue.

Donc exploitable.

Phase 1 : Sélection

Les sujets officiels sont biaisés.

Ils arrivent avec :

- une identité
- une histoire
- une résistance

Les sujets idéaux sont ceux qui ont vécu des malheurs.

Phase 2 : Altération

Le gaz est essentiel.

Il ne détruit pas.

Il ouvre.

- perception amplifiée
- filtres cognitifs affaiblis
- réalité rendue instable

Le sujet devient réceptif.

Phase 3 : Saturation

La vidéo illustre une théorie :

elle n'a pas besoin de sens en soi.

Au contraire, le cerveau est invité à :

- chercher une logique
- ne pas en trouver
- créer sa propre interprétation

C'est à ce moment précis que la fracture apparaît.

Phase 4 : Implantation

Puis vient la figure hallucinations qui exacerbe le sentiment de peur et la paranoïa.

Pas imposé de manière identique.

Jamais.

Chaque cerveau le génère différemment.

Donc chaque résultat est pur.

Ce n'est pas moi qui crée l'hallucination.

C'est le sujet qui la rend réelle.

OBSERVATIONS

Les réactions sont... instructives.

- Sujet A : agressivité immédiate
- → rejet violent de l'intrusion
- Sujet B : dissociation complète
- → abandon total de la réalité
- Autres sujets :
 - négociation
 - peur persistante

certains comprennent qu'il n'est pas réel.

Et pourtant...

ils continuent de le voir.

RÉSULTAT

Validé.

Le cerveau peut :

- créer une entité inexistante
- l'intégrer comme réelle

- maintenir cette perception dans le temps

Sans stimulation continue.

CONCLUSION

La réalité n'est pas extérieure.

Elle est générée.

Donc modifiable.

Donc contrôlable.

APPLICATION

Implanter une peur.

Implanter une présence.

Implanter une vérité.

Puis observer.

Corriger.

Recommencer.

NOTE PERSONNELLE

La résistance la plus intéressante reste celle des sujets conscients.

Ceux qui comprennent.

Ceux qui luttent.

Ceux qui refusent.

Iris Malone

Elle en fait partie.

Elle ne se brisera pas facilement.

C'est précisément pour cela...

qu'elle a de la valeur.

DERNIÈRE LIGNE

Ils pensent que je détruis l'esprit.

Ils se trompent.

Je révèle simplement...

à quel point il n'a jamais été solide.

SUJETS D'OBSERVATION

Certains noms méritent d'être conservés.

Elise Parker

- Sujet intéressant. Résistance émotionnelle élevée. Dissociation complète
- Poussée trop loin.
- Résultat incomplet.

Daniel Hayes

- Instabilité persistante.
- Conscience partielle des pertes.
- Potentiel d'étude post-expérience.

Maya Rodriguez

- Disparition administrative.
- Résultat... non archivé.

Ethan Cole

- Défaillance rapide.
- Données récupérées avant arrêt.
- Violence

INTERFÉRENCES EXTÉRIEURES**Agent Claire Donovan**

- Curiosité institutionnelle.
- Rapidement neutralisée. Cobaye vite décédé.

Leo Carter

- Tentative de diffusion.
- Échec prévisible. Résultat non concluant.

PROTOCOLE – INDUCTION SENSORIELLE FORCÉE

Dr Viktor Koskov

1. Capture et transfert

- Le sujet est enlevé discrètement
- Transport vers une salle isolée (sans fenêtres, sans repères)
- Aucune interaction verbale inutile

2. Installation

- Le sujet est attaché sur une chaise médicale
- Immobilisation des bras, jambes et tête
- Position forcée face à un écran

3. Préparation neurologique

- Pose d'électrodes sur le crâne :
 - tempes
 - front
 - arrière du crâne
- Connexion à un dispositif de stimulation
- Vérification des constantes

4. Altération chimique

- Diffusion d'un gaz psychoactif dans la pièce
- Inhalation progressive par le sujet
- Effets recherchés :
 - perception altérée
 - baisse des défenses mentales
 - hypersensibilité sensorielle

5. Phase d'exposition visuelle

- Lancement d'une vidéo perturbante :
 - images incohérentes
 - visages déformés
 - séquences sans logique
- Durée prolongée
- Objectif :
 - saturer le cerveau
 - empêcher toute compréhension

6. Phase de rupture

- Le cerveau tente de donner un sens... puis échoue
- Début de désorientation profonde
- Perte de repères cognitifs

7. Déclenchement auditif

- Perception d'une musique faible et répétitive
- Perçue uniquement par le sujet
- Sert d'ancrage mental

8. Induction de l'entité

- Apparition d'une figure (hallucinations) :
 - invisible pour les autres
 - différente selon le sujet
- Le sujet :
 - le voit

9. Observation

- Aucune intervention directe
- Surveillance des réactions :
 - peur
 - agressivité
 - dissociation
- Notation précise des comportements

10. Amplification (si nécessaire)

- Stimulation par électrochoc
- Répétition de la séquence de modulation sensorielle

11. Résultat

- Différant d'un patient a un autre.

NOTE INTERNE (NON SIGNÉE)

"Sujet instable mais résultats exploitables. Ajuster paramètres pour prochains cas."

INCIDENT MEDICAL MAJEUR

Date : 17/07/2025

Heure : 22h14

Événement : arrêt cardiaque durant séance PRC

Réanimation : tentative pendant 6 minutes

Issue : décès constaté à 22h20

CAUSE OFFICIELLE DU DÉCÈS
Arrêt cardiaque consécutif à une réaction imprévisible au traitement.

Le stock de gaz atteint un niveau critique, je risque de devoir stopper mes recherches.